

## **Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)**

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David  
Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP

### **Definición**

Presencia de tres síntomas fundamentales:

1. Disminución de la atención.
2. Impulsividad.
3. Hiperactividad.

### **Prevalencia**

Los últimos estudios epidemiológicos dan cifras que rondan el 20%, es muy similar en ambos sexos, si bien parece que en los varones puede predominar la hiperactividad y en las mujeres el déficit de atención.

### **Etiología**

Es un cuadro orgánico, con origen en deficiencias anatómico-biológicas que afectan preferentemente a ciertas estructuras cerebrales.

La etiología puede ser tanto genética (autosómica dominante) como adquirida, se está observando un importante aumento de este último grupo debido fundamentalmente al gran número de niños prematuros y de peso muy bajo, a veces provenientes de partos múltiples y cuidados intensivos neonatales, predominando en sus secuelas la inquietud, la falta de atención y la impulsividad.

### **Patogenia**

Existe un trastorno funcional en el que hay una afectación conexión entre los lóbulos frontales y los núcleos basales, que afectan tanto al transporte como a la recaptación de la dopamina y en menor grado, de la serotonina y de la norepinefrina.

### **Clínica**

Tiene diferente expresión según la edad y sexo.

Durante el primer año, los niños suelen dormir mal y estar con los ojos muy abiertos y algunos comienzan a andar excesivamente pronto (entre los 6-10 meses), aunque la mayoría marcha sin ayuda algo tarde. Posteriormente muestran hipotonía, pies plano valgus y miedo a dormir solos por lo que no permiten que se apague la luz.

Durante los seis primeros años de vida la característica que mejor define a estos niños es su concepto vital – el mundo se circunscribe a ellos, y los demás son el entorno que les tiene que servir – mostrándose torpes para la motricidad fina, inquietos, caprichosos, entrometidos, acaparadores, egoístas y con poca capacidad de frustración.

Durante la edad escolar se muestran dispersos, infantiles, inmaduros, mienten y pueden sustraer dinero en casa, se levantan del pupitre muchas veces, interrumpen a otros niños y a profesores, les cuesta aprender a leer y escribir, tienen dificultades especialmente para las Matemáticas y la Lengua, presentan fracaso escolar con mucha frecuencia, muestran su falta de habilidad motriz tanto en el manejo del lápiz y cuchara como en los deportes de habilidad (ej: el fútbol).

En épocas prepuberales siguen presentando las mismas alteraciones descritas y, además, muestran sus tendencias al machismo, exhibicionismo y ausencia de sentido del ridículo (ej: se dejan cabello excesivamente largo o corto, o bien se lo tiñen).

Comienzan pronto a ser expulsados de los colegios por su bajo rendimiento y por su comportamiento conflictivo.

Durante la pubertad y vida adulta joven pueden comenzar o continuar los grandes problemas, tales como fracaso escolar y laboral, drogadicción.

### **Criterios del DSM-IV para el diagnóstico del TDAH**

El diagnóstico requiere evidencia de los tres signos fundamentales del síndrome:

Déficit de atención, impulsividad e hiperactividad.

#### **Déficit de atención**

Seis o más de los siguientes síntomas persistiendo por al menos seis meses a un grado que es mala adaptación e inconsistente con el nivel de desarrollo que debería tener el paciente:

- Fallo para prestar atención profundamente a los detalles

- Dificultad para sostener la atención en las actividades
- No escucha cuando se le habla directamente
- No sigue las instrucciones que se le dan
- Dificultades para seguir conversaciones
- Evita las conversaciones que requieren esfuerzo mental sostenido
- Pierde u olvida cosas necesarias para las actividades
- Se distrae fácilmente por estímulos externos
- Es olvidadizo en las actividades diarias

Persistencia, por al menos durante seis meses, de seis de los siguientes síntomas:

### **Hiperactividad**

- Es intranquilo
- Se levanta del asiento cuando debería permanecer sentado
- Va de un sitio para otro en situaciones en las que debería estar quieto
- Tiene dificultades para jugar sosegadamente
- Actúa como si "estuviera movido por un motor"
- Habla excesivamente

### **Impulsividad**

- Contesta las preguntas antes de serle formuladas
- Tiene dificultades para esperar su turno
- Interrumpe o molesta a los otros niños

### **Trastornos comórbidos**

Indica el añadir factores desfavorables a los tres signos fundamentales del TDAH.

- Problemas de afectividad ( no dan besos, sólo ponen la cara)
- Dificultades para el lenguaje y aprendizaje: fracaso escolar.
- Problemas para la conducción de vehículos y psicopatología asociada (dificultades para obtener el carnet, muchos accidentes).
- Trastornos de la coordinación motriz (más fuerza que habilidad).
- Ansiedad (mordedura de uñas, tics)
- Nula capacidad para aceptar lo evidente (no saben perder)
- Cambios de humor y síndrome bipolar
- Actitud oposicional desafiante.
- Comportamiento impulsivo-agresivo
- Comportamiento antisocial

### **Tratamiento**

El tratamiento de los niños y jóvenes con TDAH conlleva:

1. Una información adecuada a los padres de lo que es este síndrome, intentando tranquilizar. Este síndrome persiste siempre, pero la mayoría pueden llevar vidas normales.
2. Apoyo psicológico, muchas veces más necesario para los padres que para los propios pacientes

Farmacológico: las sustancias estimulantes suelen calmar a estos pacientes y las tranquilizantes los ponen más nerviosos. No hay inconveniente, por tanto, en recomendar bebidas de cola con cafeína o bien café, además de los fármacos estimulantes principalmente **metilfenidato** de liberación rápida o de liberación lenta. EA: crisis epilépticas, tics, glaucoma, etc, por ello, conviene comenzar siempre por dosis pequeñas para comprobar tolerancia. Las dosis, en una y otra presentación, están entre 0,3 y 1 mg/Kg/día. Se puede administrar todos los días o bien descansar las fechas en las que no hay actividad escolar.

Otra sustancia eficaz puede ser la dextro-anfetamina en dosis de 0.15 a 0.40 mg/Kg/día, repartida también en dos tomas, de forma análoga a la aplicación del metilfenidato.

También resultan muy eficaces las sustancias antiobsesivas, tipo risperidona.